

球囊-面罩通气 · OSCE

监督下模拟站 · 建议 8 分钟（含反馈）

学员编码：_____ 教师：_____ 日期：_____

可观察的行为	0 / 1 / 2	记录与反馈
准备与感染防护 核对人员、监护、面罩及球囊准备，完成感染防护。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
气道开放与面罩密闭 在模型上开放气道，与助手配合形成面罩密闭。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
有效通气观察 观察胸廓运动、漏气与氧合趋势，报告通气效果。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
失败识别 识别密闭或通气无效，说明停止点和升级需求。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
团队沟通 明确角色，用闭环语言交接效果与未解决问题。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	

0 未完成/不安全；1 提示后完成；2 监督下无需提示完成。

本轮合计：____ / 10；关键安全偏差：☐ 无观察到 ☐ 有（另记录）

关键偏差/升级/复评记录：

下一轮改进一项：

形成性核对单，未作测量学验证。评分反映本次模拟行为，不替代资质和本地操作授权。

来源定位：WHO-ICRC BEC 气道/呼吸训练；NICE NG39 严重创伤气道升级；BTS 成人急救氧疗目标；RCUK/ERC 2025 急救氧疗；DAS 颈椎损伤气道管理。

创伤气管插管 · OSCE

监督下模拟站 · 建议 8 分钟（含反馈）

学员编码：_____ 教师：_____ 日期：_____

可观察的行为	0 / 1 / 2	记录与反馈
计划与角色 说明主计划、备选计划、角色和失败停止点。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
氧合与监护准备 核查氧合、器材和监护准备，遵循本站清单。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
模拟操作流程 在训练器上按获授权清单完成受监督演练。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
客观确认 提出客观位置与通气效果确认，不能只凭胸廓运动。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
困难气道升级沟通 宣告失败并启动团队救援沟通，交接后续监护。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	

0 未完成/不安全；1 提示后完成；2 监督下无需提示完成。

本轮合计：____ / 10；关键安全偏差：☐ 无观察到 ☐ 有（另记录）

关键偏差/升级/复评记录：

下一轮改进一项：

形成性核对单，未作测量学验证。评分反映本次模拟行为，不替代资质和本地操作授权。

来源定位：NICE NG39 气道管理建议；DAS 2025 成人意外困难插管指南与教育包；ATLS 11 公开课程框架。

紧急颈前气道 · OSCE

监督下模拟站 · 建议 8 分钟（含反馈）

学员编码：_____ 教师：_____ 日期：_____

可观察的行为	0 / 1 / 2	记录与反馈
状态识别 识别并宣告失败气道危机。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
解剖定位 在模型上定位表面解剖并核对训练装置。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
危机资源管理 点名操作者、助手、监护与记录角色。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
模型操作 在专用训练器按本站清单完成受监督演练。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
确认与复盘 核查通气，复盘延误、沟通和后续交接。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	

0 未完成/不安全；1 提示后完成；2 监督下无需提示完成。

本轮合计：____ / 10；关键安全偏差：☐ 无观察到 ☐ 有（另记录）

关键偏差/升级/复评记录：

下一轮改进一项：

形成性核对单，未作测量学验证。评分反映本次模拟行为，不替代资质和本地操作授权。

来源定位：DAS 2025 困难插管 Plan D 教育材料；NICE NG39 插管失败后的救援气道框架；ATLS 11 公开课程框架。

胸腔紧急减压训练 · OSCE

监督下模拟站 · 建议 8 分钟（含反馈）

学员编码：_____ 教师：_____ 日期：_____

可观察的行为	0 / 1 / 2	记录与反馈
风险识别 整合胸部查体、呼吸和循环的变化。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
时效与优先级 说明时间敏感风险与优先级，避免等待单一影像。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
模型技术 在模型上按本地技能清单受监督演练。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
效果核查 核查效果与持续风险，识别无改善。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
复评报告 回到 xABCDE，报告变化及进一步团队需求。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	

0 未完成/不安全；1 提示后完成；2 监督下无需提示完成。

本轮合计：____ / 10；关键安全偏差：☐ 无观察到 ☐ 有（另记录）

关键偏差/升级/复评记录：

下一轮改进一项：

形成性核对单，未作测量学验证。评分反映本次模拟行为，不替代资质和本地操作授权。

来源定位：NICE NG39 胸部减压建议；WSES-AAST 2025 胸部创伤指南；ATLS 11 公开课程框架。

胸腔闭式引流 · OSCE

监督下模拟站 · 建议 8 分钟（含反馈）

学员编码：_____ 教师：_____ 日期：_____

可观察的行为	0 / 1 / 2	记录与反馈
适用场景解释 说明胸膜腔问题、目标与本地授权范围。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
准备与无菌 执行核对、无菌、监护及团队准备。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
模型操作 在胸壁模型按本地清单完成受监督演练。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
系统核查 核查连接系统、患者反应与影像信息。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
记录和团队交接 记录并交接引流、监护和复评重点。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	

0 未完成/不安全；1 提示后完成；2 监督下无需提示完成。

本轮合计：____ / 10；关键安全偏差：☐ 无观察到 ☐ 有（另记录）

关键偏差/升级/复评记录：

下一轮改进一项：

形成性核对单，未作测量学验证。评分反映本次模拟行为，不替代资质和本地操作授权。

来源定位：WSES-AAST 2025 胸部创伤指南；NICE NG39 胸腔减压与引流建议；ATLS 11 公开课程框架。

EFAST 床旁超声 · OSCE

监督下模拟站 · 建议 8 分钟（含反馈）

学员编码：_____ 教师：_____ 日期：_____

可观察的行为	0 / 1 / 2	记录与反馈
窗口与探头方向 说明窗口、探头方向及每个窗口的问题。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
图像质量 取得可解释的图像；质量不足时明确不可判读。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
结构识别 识别目标结构，区分正常、异常与不确定。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
报告语言 用标准语言报告发现与局限。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
局限与临床整合 将结果放回 xABCDE；阴性结果不独立排除损伤。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	

0 未完成/不安全；1 提示后完成；2 监督下无需提示完成。

本轮合计：____ / 10；关键安全偏差：☐ 无观察到 ☐ 有（另记录）

关键偏差/升级/复评记录：

下一轮改进一项：

形成性核对单，未作测量学验证。评分反映本次模拟行为，不替代资质和本地操作授权。

来源定位：AIUM EFAST 实践参数的完整检查与记录最低标准；NICE NG39 对 eFAST/FAST 的使用范围和阴性结果局限；WHO BEC 系统评估框架。

止血带应用 · OSCE

监督下模拟站 · 建议 8 分钟（含反馈）

学员编码：_____ 教师：_____ 日期：_____

可观察的行为	0 / 1 / 2	记录与反馈
场景与出血识别 识别危及生命的肢体出血及整体优先级。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
装置准备 核对装置准备并说明压迫、填塞与止血带情境。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
模型应用 在出血控制模型按本地清单受监督演练。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
效果核查 核查出血控制和肢体状态，报告无效。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
时间记录与交接 记录应用时间并交接装置和持续复评。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	

0 未完成/不安全；1 提示后完成；2 监督下无需提示完成。

本轮合计：____ / 10；关键安全偏差：☐ 无观察到 ☐ 有（另记录）

关键偏差/升级/复评记录：

下一轮改进一项：

形成性核对单，未作测量学验证。评分反映本次模拟行为，不替代资质和本地操作授权。

来源定位：NICE NG39 外出血与止血带建议；ACS Stop the Bleed 公开训练资源。

骨盆束带固定 · OSCE

监督下模拟站 · 建议 8 分钟（含反馈）

学员编码：_____ 教师：_____ 日期：_____

可观察的行为	0 / 1 / 2	记录与反馈
机制与风险识别 结合机制、生理和查体说明骨盆风险。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
团队移动计划 共享装置目的、移动计划及团队角色。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
模型应用 在模型按本地清单受监督应用装置。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
位置和肢体核查 核查解剖水平、装置状态、皮肤与肢体情况。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
持续复评 记录并交接循环、皮肤与后续处置复评。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	

0 未完成/不安全；1 提示后完成；2 监督下无需提示完成。

本轮合计：____ / 10；关键安全偏差：☐ 无观察到 ☐ 有（另记录）

关键偏差/升级/复评记录：

下一轮改进一项：

形成性核对单，未作测量学验证。评分反映本次模拟行为，不替代资质和本地操作授权。

来源定位：NICE NG39 骨盆束带建议；WSES 2017 骨盆创伤分类与指南；ATLS 11 公开课程框架。

四肢临时固定·OSCE

监督下模拟站·建议 8 分钟（含反馈）

学员编码：_____ 教师：_____ 日期：_____

可观察的行为	0 / 1 / 2	记录与反馈
整体优先级 先说明整体创伤优先级，再进入肢体任务。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
伤口与软组织观察 描述畸形、开放伤、软组织和皮肤情况。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
神经血管基线 记录固定前神经血管基线。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
模型固定 在模型按损伤模式和本地清单受监督固定。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
固定后复查与交接 固定后复查并记录皮肤、疼痛和神经血管变化，明确交接责任。	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	

0 未完成/不安全；1 提示后完成；2 监督下无需提示完成。

本轮合计：____ / 10；关键安全偏差：☐ 无观察到 ☐ 有（另记录）

关键偏差/升级/复评记录：

下一轮改进一项：

形成性核对单，未作测量学验证。评分反映本次模拟行为，不替代资质和本地操作授权。

来源定位：AO Surgery Reference 伤情评估、神经血管记录和临时固定原则；ATLS 11 公开课程框架；NICE NG39 重大创伤总体路径。